

Información Paciente

Nombre : Jose Domingo Vargas Marin

Edad : 58a 5m 15d

Dirección : Cordillera De La Sal 2413 Portal Andino

Rut : 9.856.887-5

Fecha Nacto: 03/10/1963

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0605884

Sexo : Masculino

Teléfono : 9 9314 4912

N° Epicrisis

299808

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 26/02/2022 20:10

Días Estadía: 20

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 18/03/2022 07:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Jose Vargas Marin 58 años

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

-Hipertensión arterial

-Nefritis en la infancia que evoluciona con ERC etapa V con hemodiálisis trisemanal por FAV , hasta trasplante renal hace 5 años.

Medicamentos: Ciclosporina, Acido micofenolico, Atorvastatina, Losartan

Aqx: trasplante renal hace 5 años

Alergia: No refiere

Inmunizaciones 4 dosis covid- 19

ENFERMEDAD ACTUAL Y RAZON DE HOSPITALIZACIÓN:

Paciente con diagnóstico de COVID 19 FIS 12/02. Consulta nuevamente por disnea con lo cual consulta al SAPU, donde se evidencia desaturación de 80 %, dado requerimientos de oxígeno se decide trasladar al servicio de urgencia el 26/2/22

Paciente ingresa con taquipnea, uso de músculos accesorios, con MAF en 9Lts, con tendencia a la hipotensión PAM 60 Se indica conectar a CNAF, se solicitan exámenes Creat 5.6 BUN 115 K 5.49 7.19/39/74/14/-13/92% PAFI 123.

Paciente evoluciona con mala mecánica ventilatoria, sin buena respuesta a CNAF, se decide intubar.

Cormack 3, 2do operador por laringoespasma. TOT 7.2, fijado a 21 cm.

NAD 0.3, bicarbonato 2/3M 250 cc, fentanilo 200 mcg, etomidato 20 mg, rocuronio 120 mg. Sedoanalgesia fenta/mida.

En estas condiciones paciente es trasladado a UCI.

Imagen de ingreso:

TC de Tórax 26/02/22: Pulmones son de volumen normal, identificando múltiples y extensos focos de condensación con densidad vidrio esmerilado con área engrosamiento septal con caracteres de empedrado y zona discretamente más condensantes en LID, estos compromete aproximadamente 50% del parénquima pulmonar, mayor a derecha.

Fecha Epicrisis : 18/03/2022 07:47

Página 1 de 3

EVOLUCIÓN DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Evolución 17/03/22: Paciente AM malas condiciones, hemodinamia inestable pese a DVA, sin sedación sin respuesta motora ni verbal ni ocular, en coma.

Se decide estudio con TAC de cerebro que muestra edema difuso. Actualmente en EEG para determinar si existe actividad cerebral.

Se conversa con familia pronóstico ominoso.

HDN: Paciente con requerimientos de DVA altos, evoluciona con sepsis secundario a bacteremia, sobre infección respiratoria y foco urinario, evoluciona con aumento de requerimientos para lograr metas de perfusión clínica y de macrohemodinamia.

Ventilatorio: Paciente intubado por NAC covid recibió protocolo recovery, BNM y pronó, además por sobreinfección respiratoria con CAET (+) para *Serratia* se otorgó imipenem y amikacina ajustos por antibiograma.

Infectológico: Paciente con bacteremia inicialmente por CGP tratados con vancomicina e imipenem, luego se negativizan y vuelven a ser positivos secundarios a una *Serratia marsescens* en sangre, además presenta ITU por *E. coli* sensible a carbapenémicos, y una NAVM por *Serratia* ambos en tratamiento amikacina e imipenem, todo ajustado por antibiograma respectivos.

Renal: Paciente con historia de trasplante renal con terapia inmunosupresora (todo secundario a una nefritis descrita en la infancia), Tx hace 5 años, estuvo pocos años en HD, actualmente con TRR durante hospitalización secundario a sepsis con foco respiratoria inicial.

Metabólico: Sin hiperglicemias, nutrición con glucerna.

Neurológico: Paciente 15/03 presenta PCR en dos oportunidades en ambas ocasiones AESP con ROSC a los 5 minutos con compresiones. Luego de esto paciente sin sedación y sin respuesta (ni motora ni estímulo respiratorio) se decide Ct de cerebro que muestra edema cerebral, posterior a esto se realiza EEG cursante que no muestra actividad. Con limitación del esfuerzo terapéutico.

Evoluciona con bradicardia extrema, posterior asistolia, se constata óbito 07:15 del 18/03.

Se da aviso a familia.

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Asociada a Ventilación mecánica (NAVM) -
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - NAC covid
Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica -
Shock séptico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

Fallecido

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 18/03/2022 07:47

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-03-2022 7:47:01

Página 3 de 3

INTERNO

Francisco Javier Alejandro Torres
Becado/Residente

Andrea Betina Vaquera
Médico Tratante (Staff)